

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

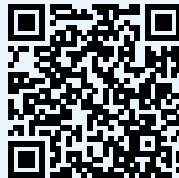
☎ 0796 222 597 / 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT & CONTEXTE CLINIQUE

Nom :	SERIDI Belgacem	ID Patient :	20260831-130
Genre :	Masculin	Durée enreg. :	625,5 min (10h 25min)
Âge :	67 ans (31/08/1959)	Taille / Poids :	172 cm / 74 kg
IMC (kg/m ²) :	25,0 (Poids normal)	Date d'enreg. :	31 Août 2026
Terrain à très haut risque : Insuffisance Rénale Chronique Terminale (IRCT) , HTA, Diabète			



Scanner pour accéder au dossier numérique du patient

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

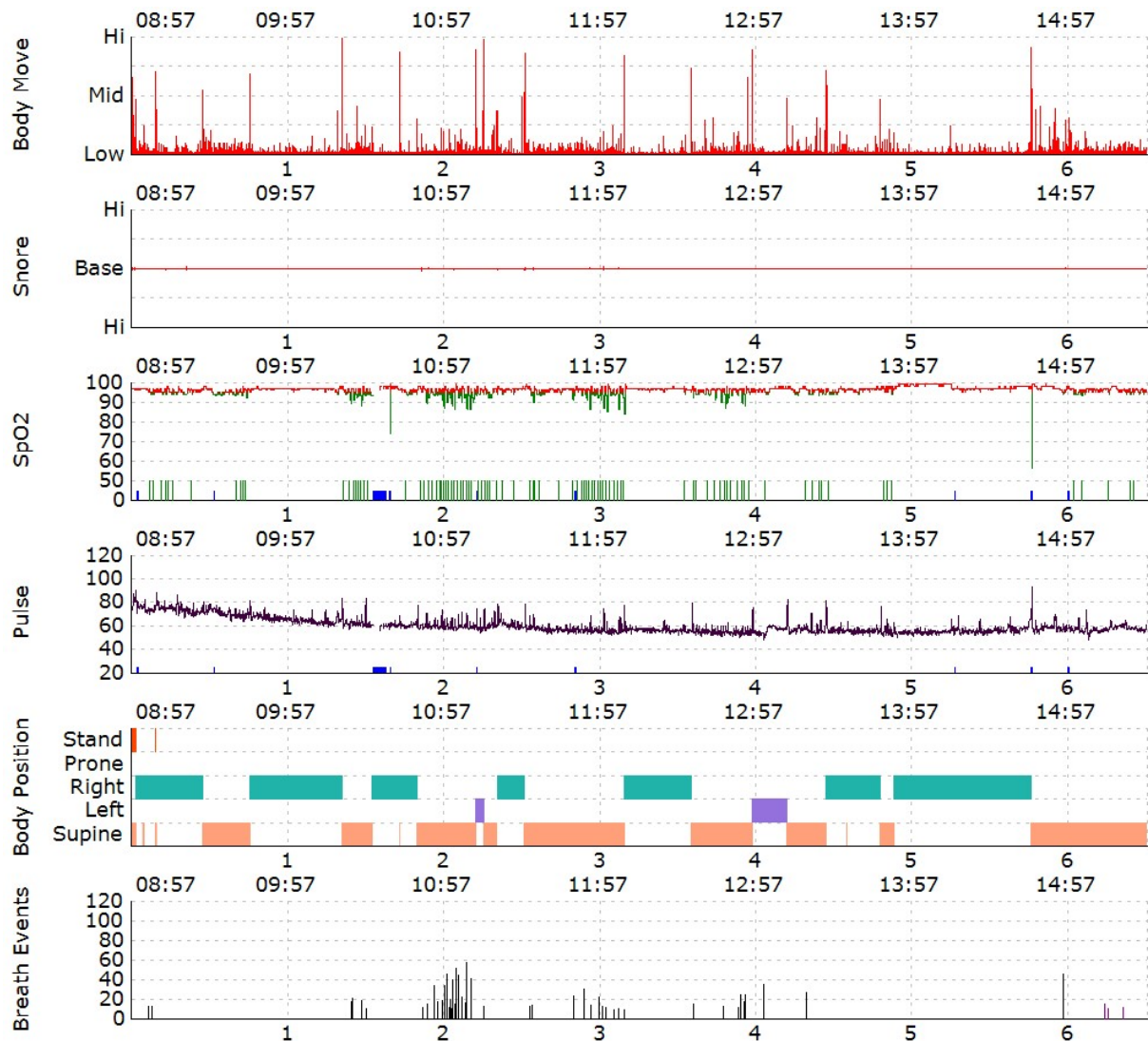


FIGURE 1 – Tracé polygraphique continu (Actimétrie, Ronflement, Oxymétrie, Pouls, Position, Événements respiratoires).

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS ET DÉPENDANCE POSTURALE

TABLE 1 – Distribution des événements respiratoires selon la posture

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	Tot. Resp.
Dorsale (SUP)	492,9	78,8	82	78	6	3	186	169
Ventrale (PRO)	1,8	0,3	0	0	0	0	0	0
Côté gauche (LAT-G)	83,2	13,3	1	3	2	1	7	7
Côté droit (LAT-D)	18,9	3,0	0	4	0	0	4	4
Debout (STAND)	28,7	4,6	0	0	0	0	9	0

2.2. ÉVÉNEMENTS DE SATURATION EN OXYGÈNE (SpO₂)

TABLE 2 – Analyse de l'oxymétrie de pouls nocturne

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Référence Clinique
SpO ₂ maximale (%)	99	95 – 100 %
SpO ₂ minimale (%)	76	≥ 90 %
SpO ₂ moyenne (%)	97	≥ 95 %
Durée totale des désaturations (min)	115,7	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO /h)	20,6	< 5 /h
Nombre total de désaturations (DO)	206	—
Temps passé sous 95% de SpO ₂ (min)	69,0	11,1 % du temps total
Temps passé sous 90% de SpO ₂ (T90 en min)	17,5	2,8 % du temps total
Temps passé sous 85% de SpO ₂ (min)	6,0	1,0 % du temps total
Temps passé sous 80% de SpO ₂ (min)	1,3	0,2 % du temps total

2.3. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – Analyse quantitative et indexation des événements

Catégorie Respiratoire	Fréquence	Indice Horaire (/h)
Apnées		
Apnées Obstructives (SAOS)	85	
Apnées Centrales (AC)	8	
Apnées Mixtes (AM)	4	
Total Apnées	97	
<i>Durée moyenne (sec) : 21,2 / Durée cumulée (min) : 34,2 (Max : 50,6 s)</i>		
Hypopnées		
Total Hypopnées	83	8,0
<i>Durée moyenne (sec) : 26,5 / Durée cumulée (min) : 36,6 (Max : 96,4 s)</i>		
Synthèse Respiratoire		
Événements globaux (Apnées + Hypopnées)	180	—
Durée cumulée des événements (min)	70,8	—
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	—	17,3
Index de Désaturation (IDO)	—	20,6
Respiratory Disturbance Index (RDI)	—	17,3

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DONNÉES

TABLE 4 – Tableau de bord synthétique du sommeil

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	97	SpO ₂ minimale (%)	76
IDO (/h)	20,6	Nombre SAOS	85
Nombre Apnées Centrales (AC)	8	Nombre Apnées Mixtes (AM)	4
Index d'Apnées (IA /h)	9,3	Nombre d'Hypopnées	83
Index d'Hypopnées (IH /h)	8,0	IAH global (/h)	17,3
Fréquence Cardiaque moy (bpm)	47,5	Index de Ronflement (/h)	0,5
Changements de Position	187	Pression P95 (cmH ₂ O)	—

4. AVIS MÉDICAL ET CLINIQUE

Diagnostic Polygraphique

Enregistrement polygraphique concluant mettant en évidence un **Syndrome d'Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) modéré** avec un **IAH à 17,3 /h**, un **IDO à 20,6 /h**, et un nadir oxymétrique sévère à **76%**.

Physiopathologie Intriquée : IRCT, Diabète, HTA & Sommeil ➤ Transfert Liquidien Rostral Nocturne (*Rostral Fluid Shift*) : La surcharge hydrosodée interdialytique favorise la migration nocturne des liquides des membres inférieurs vers les tissus mous péri-pharyngés en position allongée, créant un œdème obstructif direct. Ceci explique la prédominance quasi-exclusive des événements en **décubitus dorsal** (78,8% du temps, **IAH dorsal = 20,6 /h**).

➤ **Majeur Risque Cardiovasculaire & Rythmique :** Les désaturations sévères à 76% constituent un puissant facteur de risque de troubles du rythme et d'ischémie myocardique.

Conduite à Tenir & Stratégie Thérapeutique 1. **Traitement par Pression Positive Continue (PPC) :** Indication formelle prioritaire. La PPC est indispensable pour lever l'obstacle pharyngé, supprimer l'hypoxie nocturne intermittente, abaisser la post-charge ventriculaire gauche et protéger le système cardiovasculaire.

2. Optimisation Néphrologique & Dialytique :

- Réévaluation stricte du **poids sec** et optimisation de l'ultrafiltration en séance de dialyse afin de réduire l'œdème pharyngé.
- Contrôle rigoureux de la prise de poids interdialytique.

3. Mesures Anti-Transfert Liquidien & Posturales :

- Surélévation modérée de la tête de lit et dispositif anti-décubitus dorsal.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24